PLAIES & CICATRISATION

FICHE A5 1/10 | Le fil conducteur

Objectif. Observer, comprendre, réaliser le soin prévu, réévaluer et transmettre.

Raisonnement en 6 temps

1. Personne	2. Cause	3. Plaie	4. Objectif	5. Soin	6. Suivi
État général, douleur, mobilité, nutrition.	Traumatisme, chirurgie, pression, vasculaire, diabète…	Site, dimensions, tissus, exsudat, berges, pourtour.	Protéger, absorber, décharger, préserver.	Prescription/ protocole, hygiène, confort.	Comparer, tracer, alerter.

- Le pansement ne remplace pas le traitement de la cause.
- L’aspect seul ne suffit pas à diagnostiquer l’étiologie ni l’infection.
- Appliquer le protocole du service et demander aide/validation si doute.

Repère. Même méthode d’observation = évolution comparable.

ÉVALUATION DE LA PLAIE

FICHE A5 2/10 | Description reproductible

Repère	À noter
Localisation	Site précis, zone d’appui, dispositif.
Dimensions	Longueur, largeur, profondeur si évaluable; même méthode.
Lit	Épithélialisation, granulation, fibrine, nécrose; cavité/décollement.
Berges / peau	Fragilité, macération, rougeur, œdème, sécheresse.
Exsudat	Quantité, aspect, évolution; odeur après nettoyage si pertinente.
Douleur / évolution	Avant-pendant-après; comparaison au soin précédent.

Photographie. Selon consentement et règles institutionnelles; ne remplace ni mesures ni description.

Patient aussi

État général, mobilité, autonomie, nutrition/hydratation, diabète, vascularisation connue, traitements, allergies, vécu et objectifs.

PHASES DE CICATRISATION

FICHE A5 3/10 | Schéma mémo

Étape	À retenir
Hémostase	Caillot et arrêt du saignement.
Inflammation	Défense locale et élimination des débris.
Prolifération	Vaisseaux, fibroblastes, tissu de granulation.
Épithélialisation	Recouvrement depuis les berges.
Remodelage	Réorganisation du collagène et de la cicatrice.

Lésion	Caillot	Défense	Comblement	Recouvrement	Remodelage
→	→	→	→	→	→

Attention. Les phases se chevauchent; durée et aspect dépendent de la cause, profondeur, perfusion et état général.

FACTEURS DE RETARD

FICHE A5 4/10 | À rechercher et transmettre

Locaux	Généraux / contexte
Pression et cisaillement	Diabète
Ischémie / perfusion insuffisante	Dénutrition, apports insuffisants
Infection clinique suspectée	Tabac, déshydratation
Macération ou dessèchement	Œdème, maladie vasculaire
Tissu dévitalisé, traumatisme	Immunodépression, traitements
Douleur mal contrôlée	Mobilité réduite, maladie aiguë

Rôle IDE. Repérer, documenter, transmettre; coordonner l’évaluation. Ne pas traiter seul une cause médicale.

Étiologies courantes

Veineuse : œdème de jambe possible. Artérielle : douleur, froid, coloration anormale possibles. Diabétique : neuropathie, appui, chaussage. Pression : relief osseux ou dispositif. Ces indices orientent l’observation; ils ne suffisent pas à poser le diagnostic.

INFECTION & ALERTE

FICHE A5 5/10 | Interpréter les signes ensemble

À distinguer	Repère
Colonisation	Germes présents sans infection clinique prouvée.
Infection locale possible	Douleur nouvelle, chaleur, rougeur, œdème, pus, exsudat en hausse, tissu friable, évolution défavorable.
Extension / général	Rougeur qui s'étend, lymphangite, fièvre/frissons, altération générale. Évaluation urgente selon circuit.

- Odeur seule, couleur seule ou prélèvement positif : insuffisants pour conclure.
- Signes parfois discrets si neuropathie, ischémie, immunodépression.
- Prélèvement selon indication et protocole; ne pas retarder une alerte.

Alerter. Aggravation rapide, suspicion d'ischémie/nécrose, signes généraux, douleur disproportionnée ou plaie diabétique qui se dégrade.

Antiseptique

Pas automatique. Indication, produit, compatibilité, durée et protocole à respecter; ne pas mélanger les produits.

PANSEMENTS : CHOIX RAPIDE

FICHE A5 6/10 | Objectif + exsudat + tissus

Famille	Repère d'usage	Vigilance
Interface	Limiter adhérence/traumatisme.	Pansement secondaire si besoin.
Mousse	Exsudat modéré.	Saturation, fuite, macération.
Hydrofibre / alginate	Absorption importante; alginate parfois hémostatique.	Pas sur plaie sèche sauf indication.
Hydrogel	Plaie sèche si indiqué.	Surveiller macération.
Hydrocolloïde	Certaines plaies peu/modérément exsudatives.	Pas adapté à toutes les situations.
Film	Protection superficielle sélectionnée.	Absorption limitée.

Avant pose. Vérifier objectif, protocole, allergie, taille, fixation, douleur, compatibilité. Ne pas tasser un remplissage.

ESCARRES : CATÉGORIES

FICHE A5 7/10 | Pression ± cisaillement

Catégorie	Repère express
1	Peau intacte, rougeur persistante non blanchissable.
2	Perte partielle, derme exposé; pas de graisse visible.
3	Perte totale, tissu adipeux visible; pas de muscle/os exposé.
4	Structures profondes exposées ou palpables.
Non classable	Profondeur masquée par fibrine/escarre.
Lésion profonde suspectée	Décoloration sombre/violacée persistante ou phlyctène sanguine.

Limite. Cette classification ne s’applique pas aux plaies veineuses, artérielles ou diabétiques.

- Décharger la zone; inspecter peau et dispositifs.
- Repositionner selon plan individualisé et tolérance.
- Matelas/coussin = compléments à la prévention.
- Ne pas masser une rougeur persistante; demander validation en cas de doute.

PIED DIABÉTIQUE

FICHE A5 8/10 | Une petite plaie peut être grave

- Neuropathie : sensibilité diminuée; plaie parfois peu douloureuse.
- Artériopathie : perfusion altérée; rechercher froid, couleur anormale, nécrose.
- Inspecter peau, espaces entre orteils, points d’appui, callosités, chaussage et antécédents.
- Évaluer plaie, écoulement, rougeur, chaleur, nécrose et état général.
- Encourager inspection régulière et chaussage adapté; transmettre toute lésion.

Alerte / parcours. Plaie, infection possible, nécrose ou ischémie : évaluation rapide et coordination pluriprofessionnelle. Décharge selon le plan de soins.

Autres plaies chroniques

Ulcère veineux/artériel : rechercher l’étiologie et le bilan disponible. Compression seulement après évaluation vasculaire et selon consignes. Traiter localement sans oublier la cause.

DÉROULEMENT DU SOIN

FICHE A5 9/10 | Avant - pendant - après

Avant	Pendant	Après
Identité, prescription/protocole, allergies, douleur, information, installation, hygiène des mains.	Retrait doux; observation; nettoyage prévu; mesures; technique adaptée; confort et prévention du traumatisme.	Pansement prévu; confort/sécurité; élimination des déchets; traçabilité; transmissions et réévaluation.

Tracer

- Date/heure et localisation.
- Dimensions, tissus, berges, exsudat, peau périphérique.
- Douleur, tolérance, pansement retiré/posé, incident.
- Évolution, alerte, interlocuteur, décision et surveillance prévue.

Transmettre des faits. Comparer au soin précédent; distinguer observation et interprétation.

AUTO-TEST & LEXIQUE

FICHE A5 10/10 | Vérifie tes repères

Question	Réponse attendue
Une odeur prouve-t-elle l'infection ?	Non; interpréter avec autres signes et évolution.
Peut-on masser une rougeur d'appui persistante ?	Non; décharger et transmettre.
Toute plaie diabétique est-elle douloureuse ?	Non; neuropathie peut diminuer la douleur.
Quand choisir le pansement ?	Après évaluation, selon objectif, tissus, exsudat, peau, protocole.
Une culture positive suffit-elle ?	Non; présence microbienne ne signifie pas infection clinique.

Lexique

Exsudat : liquide de la plaie. Granulation : tissu vascularisé de réparation. Épithélialisation : recouvrement par l'épiderme. Macération : peau fragilisée par humidité excessive. Décharge : réduction de pression. Cisaillement : glissement qui déforme les tissus.

Mémo final. Évaluer la personne + la cause + la plaie; réaliser le soin prévu; réévaluer, tracer, alerter.